



F V LEIDEN ET THROMBOPHILIE :
EXPÉRIENCE DU SERVICE D'HÉMOBIOLOGIE
DU CHU CONSTANTINE.

A. YAHIAOUI¹, I. HOUAR¹, K. BOUZENDA¹

¹ Laboratoire d'HémobioLOGIE et CHTS Constantine, Algérie.

Email : aliyahia63@gmail.com

1^{er} Congrès
International De
Biologie Médical
de Sétif
24-25 OCTOBRE
2026

INTRODUCTION

Le facteur V Leiden est une mutation génétique du gène *F5* codant le facteur V de la coagulation , entrainant une résistance à la protéine C activée , il s'agit de la cause héréditaire la plus fréquente de Thrombophilie , particulièrement répandue dans la population européenne (3 à 8%) mais nettement plus rare dans les populations d'origine africaine (<1%)

Sur le plan génétique , la forme hétérozygote est la plus fréquente.

OBJECTIF

Établir un état des lieux du facteur V Leiden dans le cadre du bilan de thrombophilie , afin d'en estimer la fréquence propre à notre population.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Nous avons effectué une étude rétrospective s'étendant de janvier 2023 à mai 2026, au cours de laquelle nous avons détecté les cas de thrombophilie avec une résistance à la protéine C activée (RPCa) positive .

Le bilan complet de thrombophilie a été assuré dans notre laboratoire par STA COMPACT , COMPACT MAX .

La recherche de la RPCa s'est faite par méthode chromogénique .

L'étude génétique à la recherche de la mutation G1691A s'est faite dans des laboratoires spécialisés par manque de réactifs .

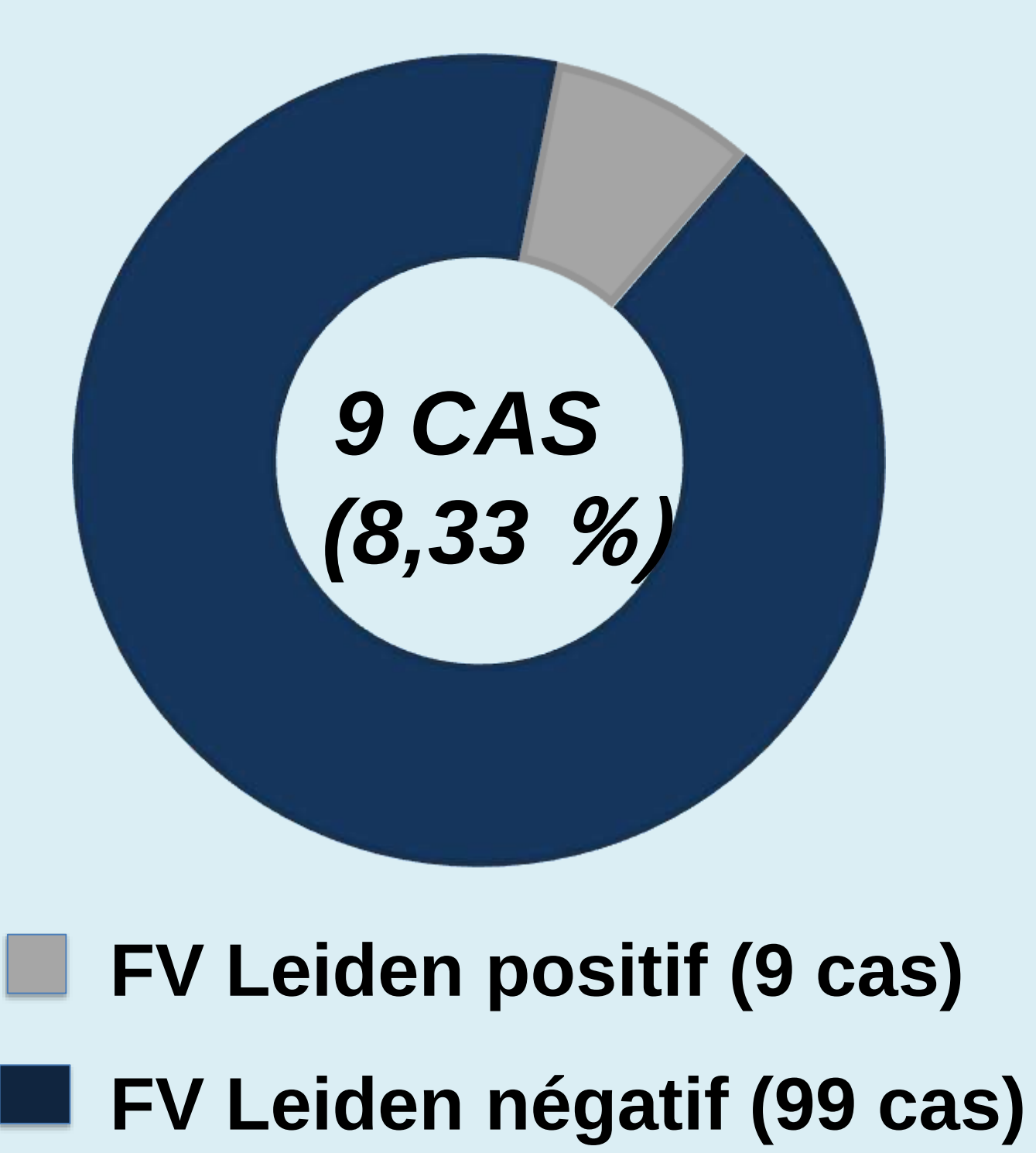


RÉSULTATS

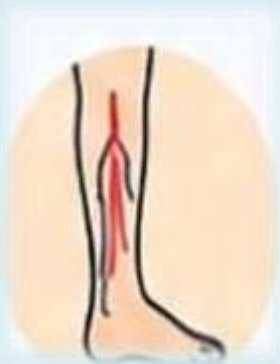
Sur 108 bilans de thrombophilie



RÉPARTITION DES CAS



CLINIQUE (Parmi les 9 cas)

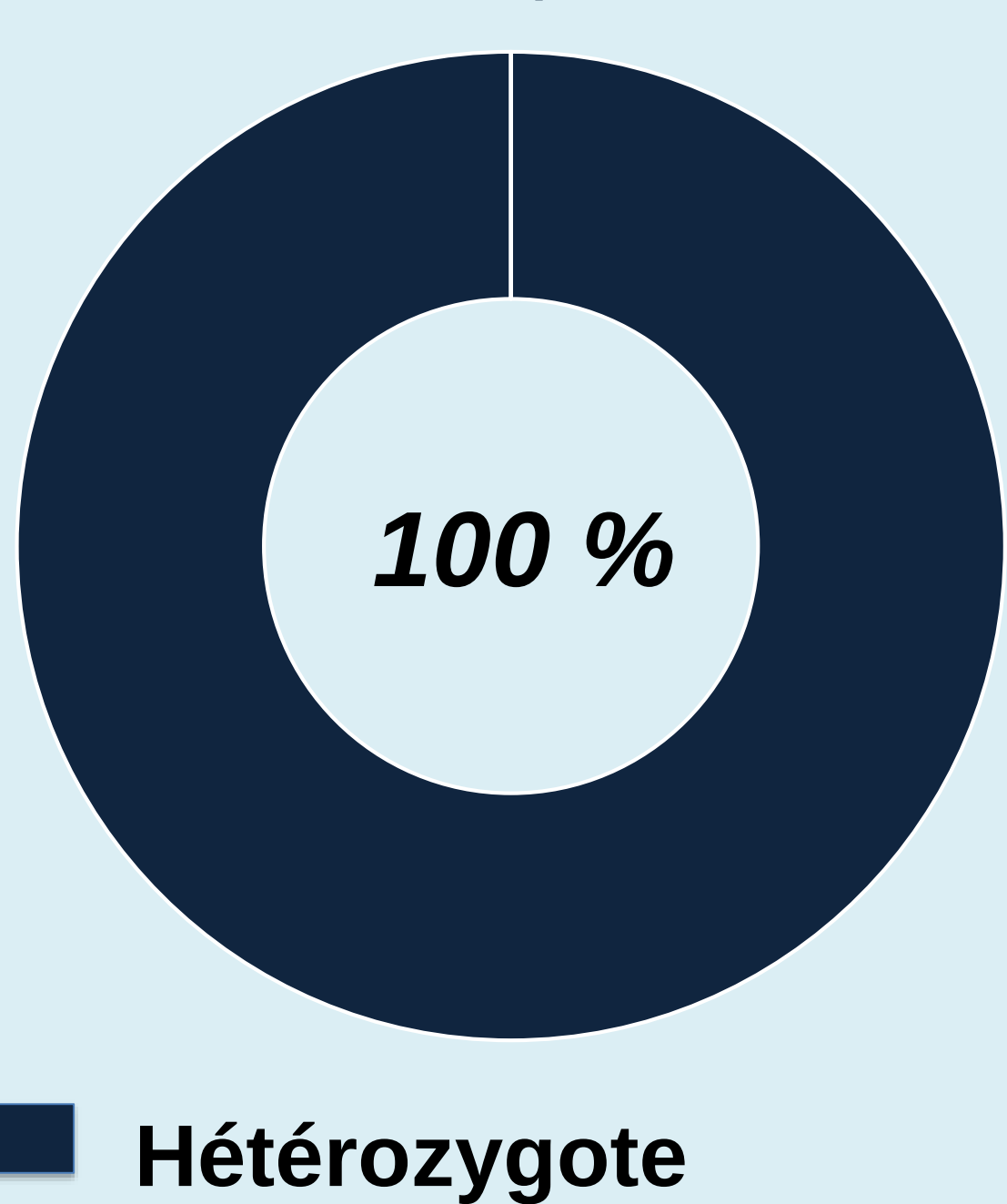


3 patients (33,3 %)
présentaient une TVP



6 patients (66,7 %)
avaient une pathologie
métabolique ou auto-immune
associée (Cushing, Bechet....)

GÉNOTYPE (Parmi les 9 cas)



DISCUSSION

Nos cas étaient tous hétérozygotes, conformément à la littérature où la prévalence hétérozygote avoisine 5 % en population .

La TVP, complication la plus fréquente, confirme le rôle classique du facteur V Leiden dans la thrombophilie , justifiant sa recherche systématique devant toute TVP du sujet jeune .

Les autres associations susmentionnées sont des facteurs de risque thrombotique additionnels, susceptibles de favoriser eux-mêmes la survenue d'une TVP.

CONCLUSION

Bien que rare dans notre population, le FV Leiden est présent et peut s'associer à diverses pathologies acquises, soulignant le caractère multifactoriel de la TVP .

RÉFÉRENCES

Kang BE, Zhang S, Lesmana H, et al. *Venous thromboembolism laboratory testing (factor V Leiden and factor II c.97G>A), 2025 revision. Genet Med. 2025;27(8):101466.

Favaloro EJ, Arunachalam S, Dean E, et al. Activated Protein C Resistance Testing: An Update From Australasia/Asia-Pacific. Int J Lab Hematol. 2025;47(4):720–729.

Pastori D, Menichelli D, Valeriani E, Pignatelli P. Factor V Leiden Thrombophilia. GeneReviews. Updated 2025.